

학생맞춤통합지원 이해 및 운영 사례

(보건교사의 역할 중심으로)

신연옥

(전 서울방화초등학교 교장)

1. 학생맞춤통합지원의 필요성과 개요

최근 교육현장은 단순한 학업 성취를 넘어 학생 개개인의 전인적 성장과 복지적 안녕을 실현하는 방향으로 나아가고 있다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 아동의 심리·정서적 불안, 가정 해체, 아동학대, 이주배경 학생 증가 등 다양한 사회적 요인이 교육현장에 복합적인 영향을 미치면서, 교내에서 감당하기 어려운 위기 상황이 빈번히 발생하고 있다. 이러한 변화에 따라 학교는 기존의 단편적 지원 방식을 넘어서 복합적 어려움에 처한 학생을 조기에 발견하고, 다양한 분야의 전문가와 지역사회 자원을 연계하여 통합적으로 지원할 수 있는 체계의 구축이 요구되었다. 이와 같은 배경에서 학생맞춤통합지원이 추진되었다.

학생맞춤통합지원은 학생 개개인의 상황과 욕구를 바탕으로 한 조기 발견, 다차원적 지원, 유관기관 연계, 정보 기반 관리 등을 통해 학생의 위기 상황을 사전에 예방하고, 실질적이고 지속 가능한 도움을 제공하고자 하는 종합적인 지원 체계이다. 특히 초등학교 보건교사는 학교 내에서 학생의 신체적 건강과 밀접하게 접촉하는 위치에 있어, 위기 징후 조기 발견 및 초기 개입의 핵심 인력으로 자리하고 있다.

2. 학생맞춤통합지원의 목적

학생맞춤통합지원의 목적은 단순히 위기 상황에 처한 학생을 식별하여 개입하는데 그치지 않고, 학생 개개인의 잠재력과 자존감을 회복시켜 건강하고 안정적인 학

교생활을 영위할 수 있도록 하는 데 있다. 특히 초등학생의 경우 정서적 안정, 안전한 환경, 양육적 관계 형성이 매우 중요한 시기이므로, 위기 상황의 예방과 조기 개입이 학생의 전 생애에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

세부적으로 다음과 같은 다섯 가지 목적이 있다.

가. 조기 발굴을 통한 예방 중심 개입

학생의 위기를 조기에 발견하고 개입함으로써, 문제 상황이 심화되거나 장기화되는 것을 방지한다. 이 과정에서 학교 내 모든 교직원이 관찰자로서의 역할을 수행하며, 이를 통해 학생에 대한 다면적 인식과 빠른 대응이 가능해진다.

나. 통합적이고 맞춤형 개입 제공

학생 개인의 상황(가정환경, 건강상태, 심리상태, 학업성취도 등)을 종합적으로 고려하여 맞춤형 개입이 이루어질 수 있도록 한다. 이는 교육, 복지, 상담, 보건, 행정 등 다양한 영역의 전문성이 결합된 통합지원체계를 통해 가능하다.

다. 다기관 연계 강화

학교 단독으로 해결하기 어려운 문제에 대해서는 지역사회 유관기관과의 유기적 협력을 통해 보다 전문적이고 지속적인 지원이 이루어질 수 있도록 한다. 이를 통해 공공자원의 효율적 활용과 중복 지원 방지가 가능하다.

라. 학생 정보의 통합적 관리

위기 학생에 대한 다양한 정보를 구조화된 방식으로 관리하고, 학급 간, 학교 간, 지역 간 연계가 가능하도록 한다. 특히 전학 시 학생의 지원 이력이 단절되지 않도록 정보의 연속성과 보호가 동시에 이루어지도록 한다.

마. 학생의 보호자 및 가정과의 협력

학부모(보호자)는 학생 지원의 중요한 협력자이다. 통합지원 체계는 보호자와의 정기적인 소통과 협의를 통해 가정 내 지원 환경까지 포함하여 학생의 삶 전체를 바라보는 관점으로 접근한다.

3. 학생맞춤통합지원의 운영 체계

학생맞춤통합지원의 운영 체계는 학교 규모, 조직 여건, 인적 자원의 배치에 따라 유연하게 설계되나, 일반적으로는 학생맞춤통합지원팀을 중심으로 구성된다. 본 팀은 학교 관리자, 교사, 전문 인력, 지역사회 자원 연계자 등이 포함된 협의체로서, 위기 학생의 조기 발굴부터 통합 진단, 맞춤형 지원 실행, 사후 점검에 이르기까지 전 과정을 공동으로 수행한다.

가. 학생맞춤통합지원 조직 구성

학생맞춤통합지원팀은 학교의 여건에 따라 구성 인원과 역할이 조정될 수 있으나, 다음과 같은 기본적인 체계를 기반으로 조직된다.

- 1) 총괄 책임자(교장): 학생맞춤통합지원 체계 전반에 대한 최종 의사결정 권한과 책임을 가진다. 외부 유관기관과의 협약, 지원 사업 운영 승인, 교내 자원 배분 등에 관여한다.
- 2) 조정자(교감 또는 생활지도 부장): 팀 내 실질적 조정자로서 회의 일정 조율, 사례 접수 및 배정, 타부서 간 의사소통 조정, 실무진 간 협력 조율 등을 담당한다.
- 3) 담임교사: 학생과 가장 밀접한 관계에 있는 교사로서, 학생의 일상생활에서 관찰한 변화나 이상 징후를 보고하며, 가정과의 소통, 개입 이후 학급 내 분위기 조성 등에서 핵심적 역할을 수행한다.
- 4) 전문상담교사: 정서적 어려움, 또래 관계, 자해·자살 위험 등과 관련된 심리검사, 개인상담, 집단상담 등의 전문 개입을 수행하며, 고위험군 학생에 대한 지

속적 모니터링을 담당한다.

- 5) 보건교사: 신체적 건강과 관련한 문제는 물론, 반복적인 신체 증상에 나타난 정서적 위기 가능성을 조기 포착하여 통합지원팀에 제공한다. 응급 상황 발생 시 초기 조치와 외부 연계도 담당한다.
- 6) 교육복지사: 가정환경, 생계, 방임, 아동학대 등 복지적 문제에 대해 전문적 개입을 수행하고, 지역사회 복지기관과의 연계 및 자원조사를 통해 실질적인 지원을 이끌어낸다.
- 7) 사서 또는 사서교사: 학생의 독서 행동을 기반으로 정서 상태를 간접적으로 파악할 수 있으며, 정서지원 독서 프로그램 기획, 문화적 접근 기반 활동 설계 등에서 기여할 수 있다.
- 8) 특수교사(해당 시): 장애 학생의 특성과 필요를 반영한 지원 계획 수립에 참여하며, 통합학급 내 상호작용과 학습 참여도에 대한 정보를 제공한다.
- 9) 행정실장 및 행정직원: 회의 운영, 예산 편성 및 집행, 외부 기관과의 문서 교류, 지원 일지 정리 등 통합지원팀의 행정적 운영을 담당한다.
- 10) 지역사회 유관기관 담당자(필요 시 초청): 정신건강복지센터, 청소년상담복지센터, 경찰, 지역의료기관, 아동보호전문기관 등의 실무자가 팀 회의에 참여하여 전문적 의견을 제공하거나 현장 지원 협의를 수행한다.

통합지원팀은 이와 같은 다분야 전문가들이 상호 협력하며, 학생 개개인의 위기 유형과 복합성에 따라 유동적으로 인력이 조정될 수 있다.

나. 절차 및 단계별 운영

1) 학생 관찰 및 조기 발견

학교 구성원 전체가 일상적 활동 속에서 학생을 관찰하며, 이상 징후를 감지할 경우 내부 보고 체계를 통해 사례로 접수한다. 보건교사의 경우, 신체 증상을 가장 먼저 접하게 되는 위치에 있어, 반복적인 복통, 두통, 상처, 수면장애 등의 증상을

통해 정서적 문제나 가정 내 위기 가능성을 유추할 수 있다.

2) 사례 접수 및 통합 진단 회의

통합지원팀은 정기 또는 수시로 사례회의를 개최하여 접수된 학생의 상황을 다각도로 분석하고, 개입 여부를 결정한다. 이 회의에서는 학업, 건강, 정서, 행동, 가정 환경 등 다양한 영역에서 수집된 정보를 바탕으로, 전문 인력 간 협의에 의해 통합 진단을 실시한다.

3) 맞춤형 지원 계획 수립 및 실행

진단 결과에 따라 개입이 필요한 경우, 학생의 상황에 맞는 지원 계획을 수립한다. 지원 계획에는 다음과 같은 영역이 포함될 수 있다.

- 심리정서 지원: 전문상담교사의 개별·집단상담, 놀이치료, 미술치료 등
- 건강 지원: 보건교사의 건강상담, 기초 건강관리, 생활습관 개선 지도
- 복지 지원: 교육복지사의 가정방문, 생계지원 연계, 지역 복지 자원 연결
- 학습 지원: 기초학력 프로그램, 학습 멘토링, 방과후 학습 지원
- 관계 및 자존감 회복 지원: 또래 관계 회복 활동, 자아존중감 프로그램

4) 모니터링 및 사후관리

지원이 실행된 이후에도 학생의 변화 양상을 지속적으로 관찰하고, 필요한 경우 추가 개입 또는 지원 조정을 시행한다. 이때 보건교사는 건강 관련 행동 변화나 재방문 양상 등을 통해 회복의 정도를 판단할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.

5) 기록 및 정보 관리

모든 사례는 개인정보 보호 규정에 따라 체계적으로 기록되며, 통합지원 플랫폼이나 학생성장기록부에 주요 내용을 등재한다. 이 정보는 중장기적 지원 지속 및 전입학 시 연계에 중요한 근거자료가 된다.

4. 보건교사의 역할

초등학교 보건교사는 학생맞춤통합지원 체계에서 다음과 같은 중추적인 역할을 수행한다.

1) 위기 징후의 조기 발견

- 보건실을 반복적으로 방문하는 학생의 행태 분석
- 신체적 증상에 내재된 정서적 문제 탐색 (예: 복통, 두통, 수면장애 등)
- 자해 흔적, 외상 빈도 등을 통해 위험 수준 판단

2) 정서적 지지 및 초기 상담

- 학생에게 심리적 안정감을 제공하고 정서적 표현을 유도
- 간단한 대화를 통해 비언어적 신호 포착 및 신뢰 형성

3) 연계 및 협업

- 통합지원팀 회의에 참여하여 학생의 건강 상태 및 행동 정보를 공유
- 전문상담교사, 담임교사, 교육복지사와의 협력을 통해 개입계획 조율

4) 예방 교육 및 건강 프로그램 운영

- 자존감 향상, 스트레스 관리, 성폭력 예방 등 위기 예방 중심의 보건 교육 운영
- 정기 건강검진 결과를 토대로 위험군 학생 선별 및 후속 관리

5. 운영 사례

가. 사례1. 정서불안으로 반복된 복통을 호소한 여학생 A

보건교사는 A학생이 주 3회 이상 복통을 호소하며 보건실을 찾는 사실에 주목하였다. 방문 기록을 분석한 결과, 가정 내 부모의 갈등으로 인한 정서불안이 원인으로 판단되었다. 통합지원팀에 의뢰 후 다음과 같은 지원이 제공되었다.

- 1) Wee클래스 정서 지원 프로그램 연계
- 2) 보건교사의 지속적 상담 및 건강지도
- 3) 교육복지사의 가정방문 및 부모 상담

결과적으로 A학생은 보건실 방문 빈도가 현저히 줄고, 학교생활의 안정성이 향상되었다.

나. 사례2. 자해 의심 상처를 입은 남학생 B

B학생은 팔에 자주 긁힌 자국과 상처를 입고 보건실을 방문하였다. 보건교사는 상처 위치와 패턴이 자해의심에 해당함을 인지하고, 즉시 전문상담교사와 연계하였다. 이후 통합지원팀이 개입하여 다음과 같은 통합적 지원이 실행되었다.

- 1) 정신건강의학과 진료 및 치료 연계
- 2) 또래관계 회복을 위한 학급 내 활동
- 3) 보건교사의 정기 모니터링 및 보건일지 기록

B학생은 점차 정서적 안정감을 회복하고 자해행동이 중단되었다.

6. 결론 및 제언

학생맞춤통합지원은 위기 학생의 조기 발굴, 통합적 진단, 맞춤형 개입, 지속 가능한 사후관리를 포함한 종합적인 학생 지원 체계이다. 초등학교 보건교사는 이러한 체계 내에서 중요한 관찰자이자 지지자, 그리고 중재자 역할을 수행할 수 있다. 향후 보건교사의 역할 강화를 위해 다음 사항이 요구된다.

첫째, 보건실 내 상담역량 제고 및 사례기록 시스템의 체계화

둘째, 통합지원팀과의 정기적 소통 구조 확립

셋째, 위기학생 대응 매뉴얼 및 체크리스트의 활용 강화

넷째, 보건교사 간 협력망 및 사례 공유 체계 마련

보건교사의 따뜻한 관심과 전문성은 학생의 위기 상황을 조기에 발견하고, 다시 건강한 학교생활로 회복할 수 있도록 하는 데 중추적인 역할을 수행할 수 있다. 이러한 전문성과 실천이 학교공동체의 안전망으로서 더욱 확대되고 강화되기를 기대한다.

(강사 E-mail : sinyeonok@gmail.com)